

MÓDULO 3.3: MANEJO DE PRODUCTOS SUJETOS A CONTROL LEGAL (PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES)

Índice de Contenidos

1. INTRODUCCIÓN ACADÉMICA
2. DESARROLLO TÉCNICO Y MARCO REGULATORIO
3. CONCLUSIÓN PRÁCTICA
4. GLOSARIO TÉCNICO

1. INTRODUCCIÓN ACADÉMICA

El manejo de sustancias controladas en Chile representa el nivel más alto de responsabilidad técnica y legal dentro de una farmacia. Estas sustancias, clasificadas como estupefacientes y psicotrópicos, poseen propiedades farmacológicas capaces de actuar sobre el Sistema Nervioso Central (SNC), pero debido a su potencial de generar dependencia física o psíquica y su riesgo de abuso, el Estado ejerce un control estricto sobre toda su cadena de valor. El Auxiliar de Farmacia debe comprender que el incumplimiento de los protocolos de custodia y expendio no solo conlleva multas administrativas, sino que puede derivar en sanciones penales y el cierre inmediato del establecimiento por parte de la autoridad sanitaria.

2. DESARROLLO TÉCNICO Y MARCO REGULATORIO

2.1 Clasificación y Marco Legal

La normativa nacional distingue dos cuerpos legales fundamentales para el control de estas sustancias:

- **Estupefacientes (Decreto Supremo 404):** Sustancias generalmente asociadas al alivio del dolor intenso (analgésicos opioides) o al tratamiento de dependencias. Se clasifican en Listas (I, II, III).
- **Psicotrópicos (Decreto Supremo 405):** Sustancias que modifican la actividad mental. Se clasifican en cuatro listas según su peligrosidad intrínseca y su utilidad terapéutica:
 - **Lista I:** Sustancias prohibidas en el territorio nacional debido a su alto riesgo y nula utilidad médica (ej: LSD, Heroína).
 - **Lista II y III:** Sustancias de control estricto que requieren Receta Cheque.
 - **Lista IV:** Sustancias de uso terapéutico masivo (ansiolíticos, hipnóticos) que requieren Receta Médica Retenida con Control de Existencia.

2.2 Almacenamiento y Seguridad Crítica

De acuerdo con el Artículo 14 del Decreto Supremo 466, la planta física de la farmacia debe contar con una estantería o mueble metálico exclusivo y bajo llave para el resguardo de estupefacientes y psicotrópicos.

- **Custodia de Llaves:** Según la normativa, el Director Técnico (Químico Farmacéutico) es el responsable directo de la tenencia, custodia y expendio de estos productos. El auxiliar asiste bajo su supervisión, pero jamás debe dejar el armario abierto ni las llaves al alcance de personal no autorizado.
- **Prohibición de Fraccionamiento:** El Artículo 40 del Decreto 466 prohíbe taxativamente el fraccionamiento de productos estupefacientes y psicotrópicos. Estos solo deben entregarse en su envase original sellado para garantizar la trazabilidad y evitar el desvío de dosis.

DESARROLLO DE CONCEPTO: MECANISMO DE ACCIÓN Y FORMA FARMACÉUTICA

Importancia Biológica: La mayoría de los psicotrópicos de la Lista IV (Benzodiazepinas) actúan uniéndose al receptor GABA-A en el cerebro, potenciando el efecto inhibitor del neurotransmisor GABA. Esto produce efectos ansiolíticos, sedantes y anticonvulsivantes. Una administración incorrecta o una sobredosis pueden causar depresión respiratoria severa.

Proceso de Fabricación: Se fabrican bajo normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Al tratarse de principios activos con potencias muy altas (dosis de 0,5 mg), la homogeneidad de la mezcla en el comprimido es crítica para asegurar que no existan unidades con dosis tóxicas o ineficaces.

Farmacocinética Básica (Liberación): Al administrarse por vía oral en forma de comprimidos, deben desintegrarse y disolverse en el tracto gastrointestinal. Su alta liposolubilidad permite que atraviesen rápidamente la barrera hematoencefálica para ejercer su efecto central.

Ejemplos en el Mercado Nacional:

- **Clonazepam 0,5 mg / 2 mg:** Comprimidos (Psicotrópico Lista IV).
- **Alprazolam 0,25 mg / 0,5 mg:** Comprimidos (Psicotrópico Lista IV).
- **Zolpidem 10 mg:** Comprimidos recubiertos (Psicotrópico Lista IV).

2.3 Documentación y Registros Oficiales

Es obligación legal mantener el Libro de Control de Estupefacientes y Psicotrópicos actualizado al minuto. Según el Artículo 18 de los Decretos 404 y 405, se deben registrar:

- **Ingresos:** Fecha, cantidad, número de factura y proveedor.
- **Egresos:** Fecha, cantidad, número de receta (cheque o retenida), nombre del médico, RUT del paciente y RUT del adquirente.

⚠ **SALDOS:** El saldo físico en el armario debe ser exactamente igual al saldo anotado en el libro. Cualquier descuadre es causal de sumario sanitario.

APLICACIÓN EN EL MESÓN

Situación: Un cliente habitual llega con una receta de Diazepam cuya fecha de emisión es de hace 35 días. Argumenta que por el paro de transporte no pudo venir antes y que necesita el medicamento para dormir.

Resolución: El auxiliar profesional debe rechazar el despacho. La normativa establece en el Art. 26 del DTO 404 y Art. 25 del DTO 405 que la vigencia de las recetas de productos controlados es de exactamente 30 días desde su emisión. Despachar una receta vencida es una infracción grave que invalida el control sanitario.

3. CONCLUSIÓN PRÁCTICA

El manejo de controlados requiere una disciplina inquebrantable. El auxiliar debe verificar que las recetas no tengan enmiendas ni espacios en blanco, exigir siempre la cédula de identidad del adquirente y nunca, bajo ninguna circunstancia, dispensar estos productos si el Químico Farmacéutico no se encuentra presente en el local para supervisar la operación.

4. GLOSARIO TÉCNICO

Estupefaciente

Sustancia con alto potencial de abuso que produce estupor o insensibilidad (opioides).

Psicotrópico

Agente químico que actúa sobre el SNC produciendo cambios temporales en la percepción o el ánimo.

Receta Cheque

Formulario oficial numerado para la prescripción de sustancias de control máximo (Listas II y III).

Receta Retenida

Prescripción médica que debe quedar archivada físicamente en la farmacia tras su despacho.

Control de Existencia

Obligación de registrar cada unidad que entra y sale del establecimiento en libros oficiales.

Adquirente

Persona mayor de 18 años que retira el medicamento y cuyos datos deben quedar registrados.

Dosis Diaria

Cantidad de fármaco que el paciente debe consumir cada 24 horas, dato obligatorio en la receta.

Enmienda

Tachadura o corrección en una receta que invalida el documento legal.

Vigencia

Plazo legal de validez de una receta (30 días para controlados).

Desvío

Acción ilegal de retirar sustancias controladas del canal farmacéutico hacia el mercado negro.